32. 下部生殖器

所要時間：08:54　学習シート

コース概要

下部生殖器系に関するこの没入型ビデオでは、膣と子宮の発生学を探求し、これらの必須構造を形成する後方成長のダイナミクスに焦点を当てます。婦人科のバランスは、仙骨と腹膜の間の動きの分析、およびこれらの相互作用が生殖器の健康にどのように影響するかを通じてアプローチされます。流産や子宮内膜症などの不均衡に焦点を当て、このビデオは、エネルギー浄化、筋膜のバランス、および世代間のつながりの概念に基づいた魅力的な治療テクニックを提案します。このアプローチにより、開業医は次のことを学ぶことができます。

下部生殖器：生体発生学的アプローチ

膣と子宮の発生学

尿生殖洞にある**ミュラー結節**への**膀胱**の挿入は不可欠です。この領域には、膀胱、尿道、および膣への付着が含まれます。

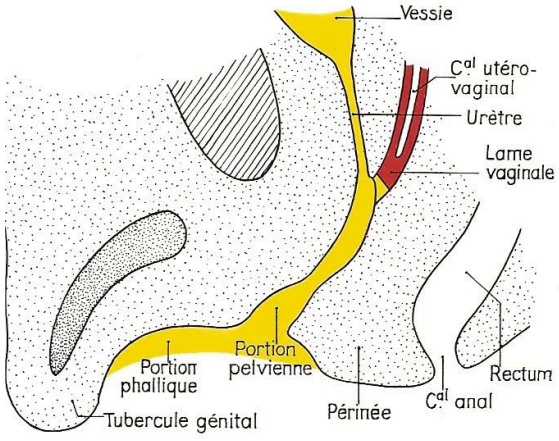


Fig. 2. — *Ouverture de la membrane uro-génitale.*

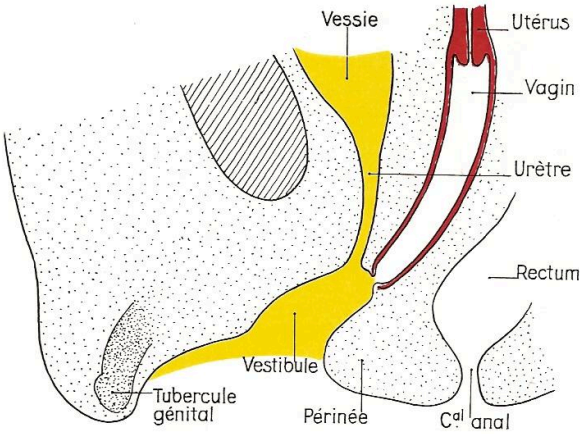


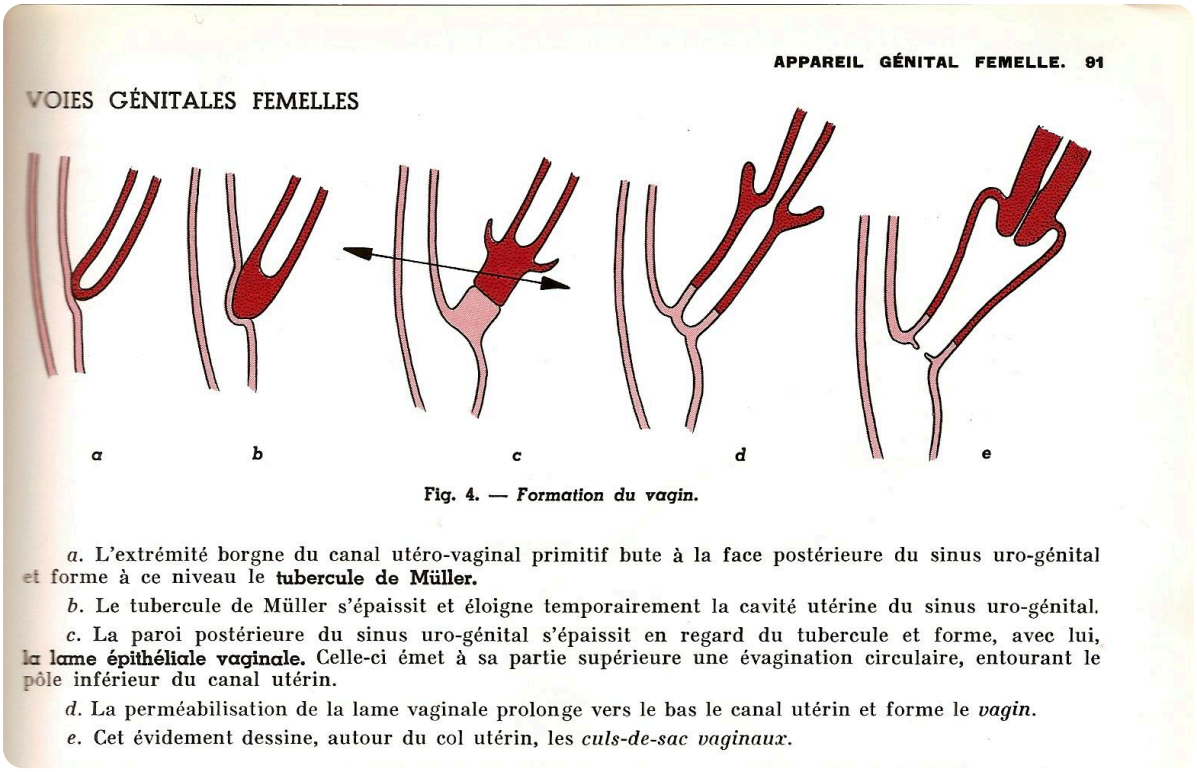
Fig. 3. — *Le vestibule définitif.*

図 — 雌の尿生殖路の発達

膣は**中胚葉**、特にミュラー管に由来します。**膣板**の形成は、仙骨と神経管の後方成長の結果です。

この後方部分の異なる成長速度が、膣の開口部空間を作り出します。この伸展を可能にするのは、腎臓と仙骨の間の**後方-前方**への動きです。

ミュラー結節は肥厚し、その後、表面的な牽引ではなく、後方部分のより速い押し出しによって引き伸ばされます。この現象は、膣と子宮頸部の伸長と形成につながります。



APPAREIL GÉNITAL FEMELLE. 91

VOIES GÉNITALES FEMELLES

a b c d e

Fig. 4. — *Formation du vagin.*

a. L'extrémité borgne du canal utéro-vaginal primitif bute à la face postérieure du sinus uro-génital et forme à ce niveau le **tubercule de Müller.**

b. Le tubercule de Müller s'épaissit et éloigne temporairement la cavité utérine du sinus uro-génital.

c. La paroi postérieure du sinus uro-génital s'épaissit en regard du tubercule et forme, avec lui, **la lame épithéliale vaginale.** Celle-ci émet à sa partie supérieure une évagination circulaire, entourant le pôle inférieur du canal utérin.

d. La perméabilisation de la lame vaginale prolonge vers le bas le canal utérin et forme le *vagin*.

e. Cet évidement dessine, autour du col utérin, les *culs-de-sac vaginaux*.

図 — 膣形成

尿生殖洞の後壁が肥厚し、開いて伸びる膣板を形成します。このダイナミクスは、後方部分がより速く成長するのと同様です。

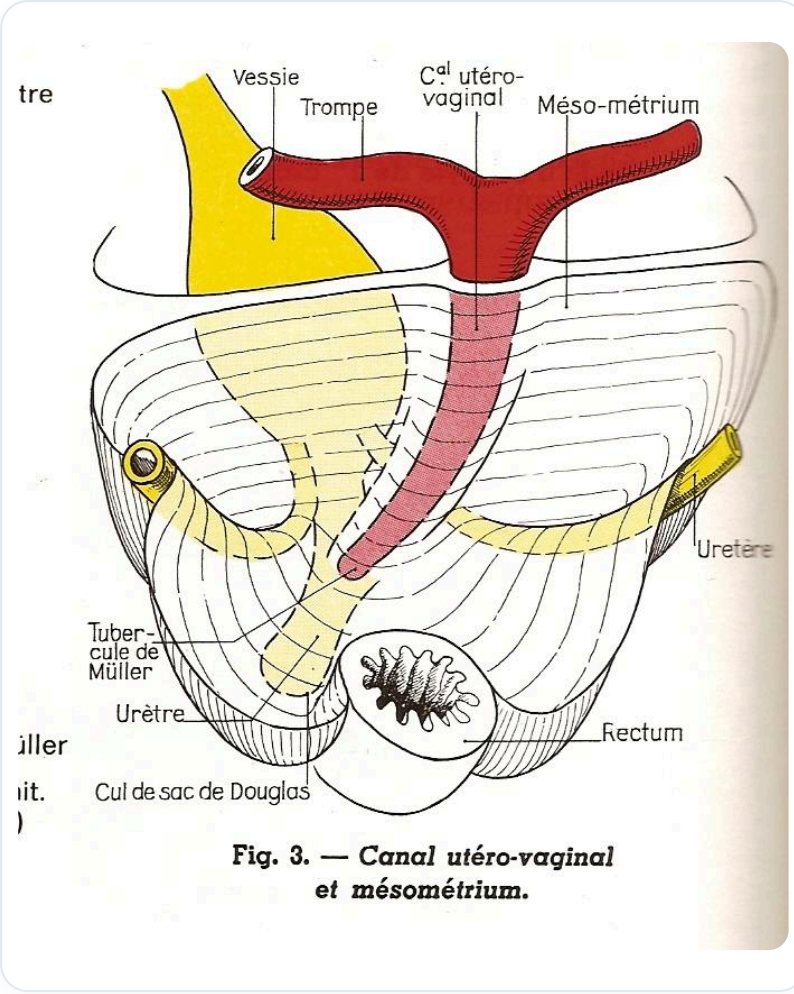


図 — 子宮膣管

婦人科のバランスと生体発生学的運動

子宮を検査すると、**仙骨**と**腹膜**の間の動きが感知されます。これら2つの極の相互作用の中に、膣と子宮のバランスがあります。

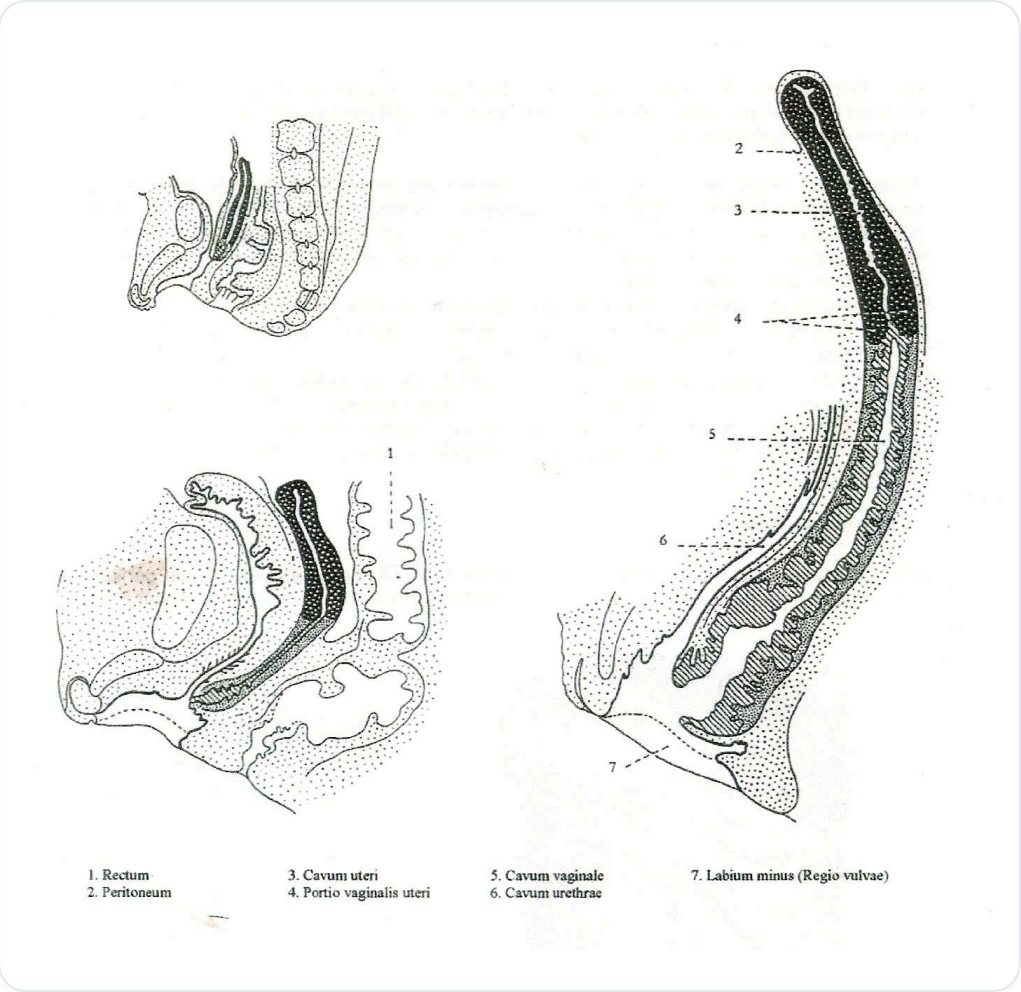


図 — 女性の子宮解剖学

性腺レベルでは、腹部で逆の動きが感じられ、靭帯に沿って恥骨に向かって、波が下がるように感じられます。

仙骨の下降は神経管の影響を受けます。もう1つの重要な支持点は、恥骨と仙骨の組み合わせであり、女性の小骨盤の不可欠な筋膜のバランスを形成します。

このバランスには、仙骨に関連する下降する力の線が含まれており、女性の体のさまざまな機能に影響を与えます。

子宮の不均衡に対する治療的アプローチ

流産のような状況は、子宮にエネルギー的な痕跡を残します。その場合、子宮のエネルギー的な浄化が必要になります。

私たちは**磁力**で子宮にアプローチし、遠隔でエネルギー場を感じることを学びます。施術者は周波数、つまり熱の領域が濃密になるのを感じ、それがエネルギーの存在の兆候です。

私のアプローチは、浄化が必要な領域を「スキャン」して特定することです。これは、組織とエネルギーに自由を取り戻すことです。

例えば、**子宮後屈**はうっ血期を引き起こす可能性があります。遠隔での作業は、**ガストリン**と密接に関連する婦人科系を再調整することを目的としています。

腹膜に組織が増殖する**子宮内膜症**は、腰痛や仙腸関節痛と関連していることが多いです。

腹腔内腔と世代を超えた次元

女性では、子宮頸部、卵管、および**腹腔内腔**の間に直接的なつながりがあります。この腔は非常に重要であり、「空」または原始的な空間として認識されています。

体の各状態は、特定の時点での可能な限り最良の機能的応答を表しています。この応答は、私たちの人生だけでなく、私たちの祖先の人生にも影響されます。

例えば、子宮後屈は、**世代を超えた**、または個人的な深い問題を解決するために体が発見した最良の応答である可能性があります。

世代を超えたパターンがなぜこのように現れるのかを理解することが不可欠です。治療は、この「最良の応答」を解読し、求められれば必要な解放を提供することを目的としています。

胚はこの概念を完璧に示しています。発達の各段階で、可能な限り最良の生理学的応答を示します。

二次神経管形成と終糸の形成

神経管は後方の尾側隆起と関連しており、光とつながりの空間を作り出しています。尾側芽と**脊索**の終端部分が観察されます。

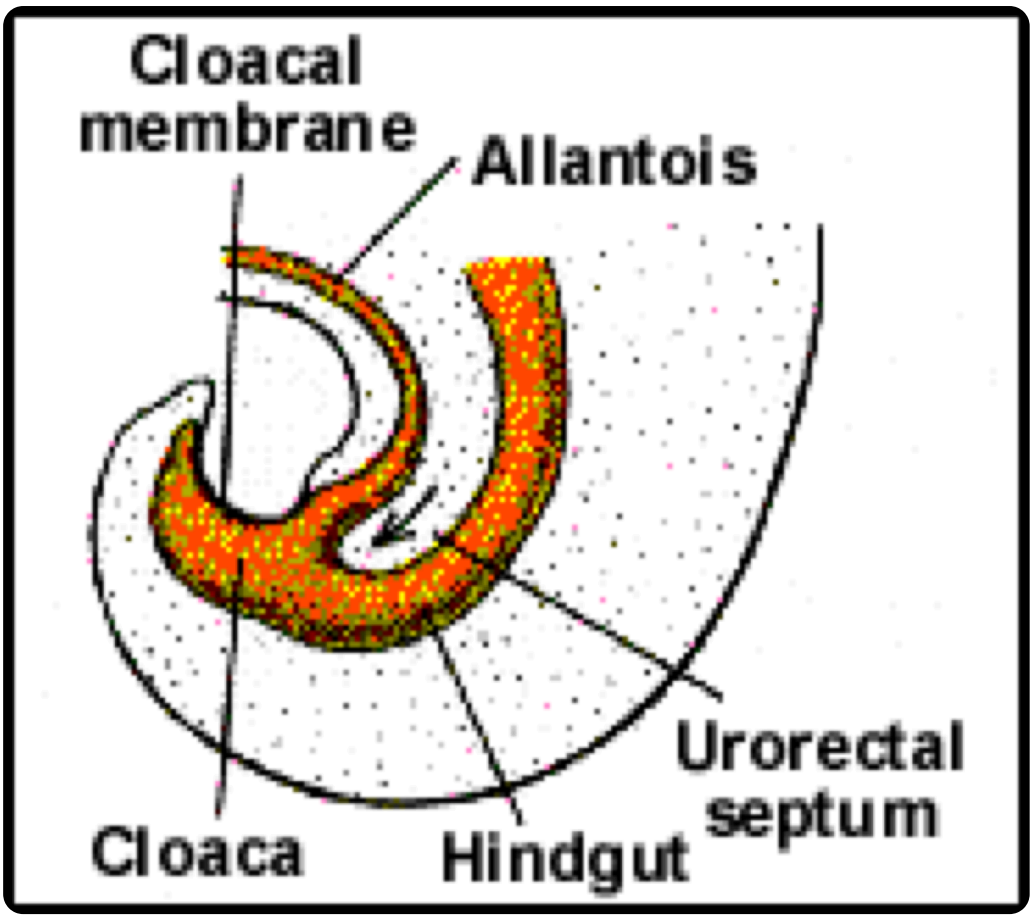


図 — 胚の総排出腔の発達

直腸の空間と、後神経孔を持つ神経管は密接な関係にあります。後方部分でより顕著な発達運動によってつながりが形成されます。

これは、このつながりを確立するために閉鎖し、その後再開することを伴います。このプロセスは、後神経孔の出現と、**終糸**を形成するための伸長につながります。

これが**二次神経管形成**と呼ばれるものです。仙骨の操作は、初期の接合部が後方に伸びるこれらの異なる成長速度を明らかにします。

尾側隆起の統合は、神経管との連続性を確保し、この上昇する二次神経管形成を形成します。

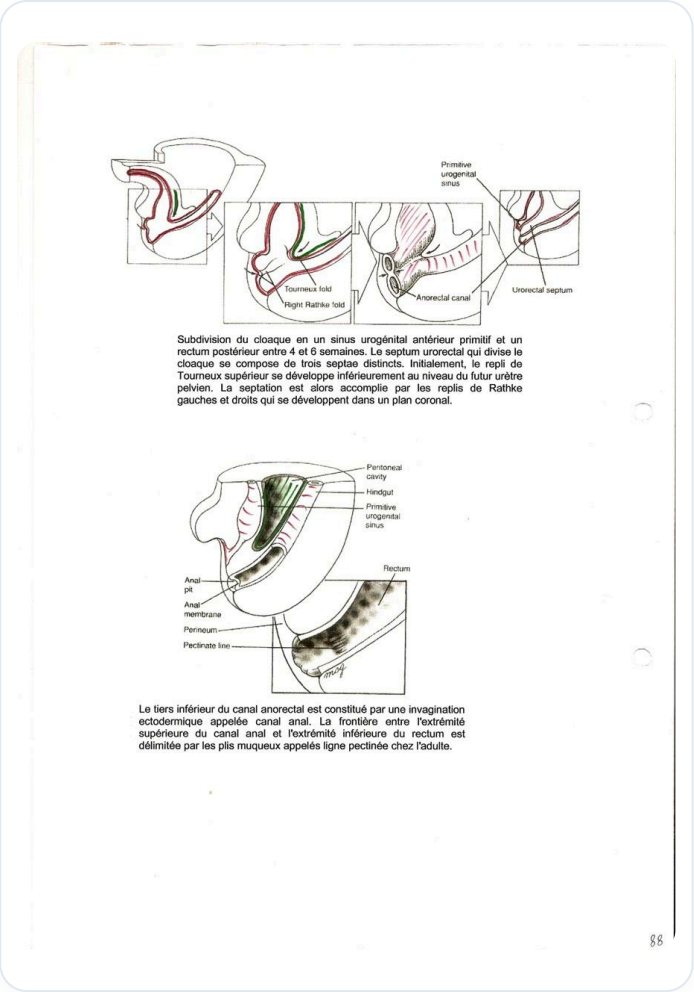


図 — 総排出腔の隔壁形成

会陰の発達と肝臓の影響

会陰レベルでは、下肢の出現と牽引が観察されます。この動きは子宮系と深く関連しています。

肝臓の傾きは、神経管と仙骨の下降と相乗的に作用し、鎌状靭帯を介して白線に向かって引っ張る発達運動に影響を与えます。

この肝臓の発達は、発達中の子宮領域全体に影響を与える傾きを引き起こします。これは、子宮の位置に関連する移動現象や異なる牽引を説明する可能性があります。

恥骨と臍の間に靭帯が発達し、下降と子宮形成の歴史をカプセル化しています。

胸骨が私たちの屈曲の歴史を含んでいるように、この腹側正中靭帯（白線上）は、後方形成、**性腺形成**、および骨盤の**子宮形成**のすべての歴史を集中させています。

白線は、**泌尿生殖器**のすべての歴史の出会いの場です。